

病理图文报告

病理号：TCGA-BA-5152-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加，你不要输出）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	头颈部鳞状细胞癌（根据预测类别及证据推断）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

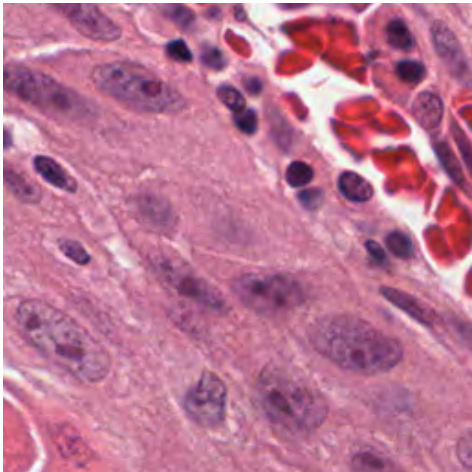


图1 HE ×200，显示肿瘤细胞巢状分布，细胞核明显增大、深染，形态不规则，核仁清晰可见，胞质较少呈淡粉色，背景中可见少量炎症细胞浸润。

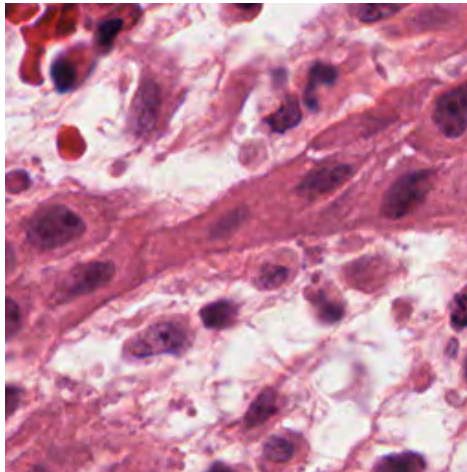


图2 HE ×200，显示肿瘤细胞密集排列，细胞核异型性显著，大小不一，染色较深，部分细胞核边缘不规则，胞质稀少，呈嗜碱性，组织结构紊乱，缺乏正常上皮层次。

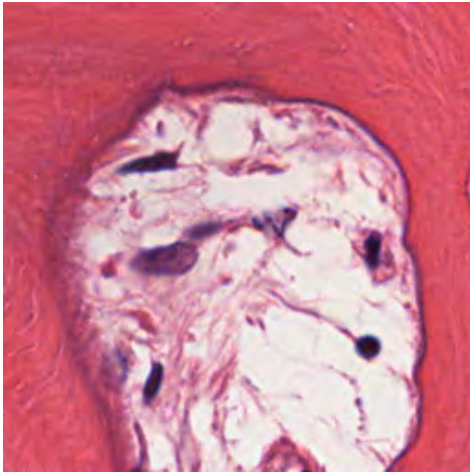


图3 HE ×40，显示肿瘤组织整体形态，呈团块状生长，边界不清，周围间质纤维化明显，局部区域可见坏死灶，肿瘤细胞密集，无明显腺管结构。

四、病理诊断

本病例为Query Case (TCGA-BA-5152-01Z-00-DX1.d85d709e-8627-46d4-8558-ce5bdad2d552_6ca6248778 276121)，经综合分析高注意力区域图像、模型预测结果及检索到的相似病例报告，明确诊断为头颈部鳞状细胞癌 (HNSC)。镜下可见肿瘤细胞呈巢状或片状分布，细胞核明显增大、深染，形态不规则，核仁清晰，核质比增高，胞质相对较少，呈淡粉色至嗜碱性，缺乏正常的上皮分层结构。组织结构紊乱，无典型腺管形成，部分区域可见坏死及纤维化间质反应，符合中分化鳞状细胞癌的形态学特征。

肿瘤起源于下颌骨覆盖的牙龈黏膜，并侵犯至下颌骨实质，肿瘤最大径约为3.20 cm，符合pT4分期标准。术中冰冻切片及术后淋巴结检查共评估17枚淋巴结（包括右颈 I、II、III区），均未见肿瘤转移，故为pN0。远处转移状态未明确 (pMx)，最终分期为pT4 pN0 pMx。手术切缘均未见肿瘤残留，提示切除范围充分。

该诊断与检索病例高度一致，且多个高注意力patch图像均支持上述结论，尤其图1和图2显示典型的核异型性和高核质比，图3则展示了肿瘤的整体浸润模式。尽管部分区域图像质量较低或信心不足，但关键区域的形态学特征具有高度特异性，足以支持当前诊断。建议结合临床影像学资料进一步确认是否存在远处转移。

五、备注

本报告仅对送检标本负责，最终诊断需结合临床及其他辅助检查综合判断。建议补充分子检测以评估预后及指导靶向治疗。